

TEMA 3.18 • OBSTETRICIA

Enfermedad Trofoblástica Gestacional (ETG)

PERFIL EUNACOM 2.01.2.020
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Enfermedad Trofoblástica Gestacional (ETG)

Clasificación

''' ETG |— Mola hidatiforme | |— Mola completa (diploide — 46 cromosomas TODOS del padre) | |— Mola parcial (triploide — 2 del padre + 1 de la madre; puede tener feto triploide inviable) |— Neoplasia trofoblástica gestacional (NTG) — cánceres |— Mola invasora |— Coriocarcinoma (más agresivo) |— Tumor del sitio de inserción placentaria (TSIP) '''

Clínica

Mola parcial

- **Metrorragia** en primera mitad del embarazo (prácticamente 100% de los casos)

Mola completa (βHCG muy elevada → múltiples síntomas)

TABLA 3.18.1: SIGNO/SÍNTOMA VS MECANISMO	
SIGNO/SÍNTOMA	MECANISMO
Metrorragia	
Altura uterina mayor a EG	Crecimiento rápido del tejido trofoblástico
Hiperemesis gravídica severa	βHCG muy alta
Preeclampsia precoz (< 20 sem)	Excepción: PE antes de 20 semanas → pensar en mola
Quistes tecaluteínicos (ovarios)	Hiperestimulación ovárica por βHCG
Hipertiroidismo	βHCG actúa sobre receptor de TSH

Neoplasia trofoblástica gestacional (NTG)

- βHCG que **persiste elevada** o se re-eleva después de evacuar una mola → diagnóstico presuntivo de NTG - También puede surgir post-aborto (mola no diagnosticada) - **Coriocarcinoma**: metástasis a pulmón (primero), cerebro, hígado - **TSIP**: aparece meses después de un parto normal → metrorragia + βHCG (+)

Diagnóstico

- **βHCG** elevada + **ETV** con imagen característica → diagnóstico de sospecha suficiente para tratar
- **Biopsia** confirma (post-evacuación o post-histerectomía)

Imágenes ecográficas de mola

TABLA 3.18.2: IMAGEN VS DESCRIPCIÓN	
IMAGEN	DESCRIPCIÓN
"Panal de abejas" o "tormenta de nieve"	Múltiples quistes intrauterinos — clásico de mola
Quistes tecaluteínicos en ovarios	Hiperestimulación ovárica por βHCG

Tratamiento

Mola hidatiforme

- **Evacuación uterina** — AMEU o legrado
- Molas muy grandes → **histerectomía** (riesgo de retención de restos)
- **Biopsia** del material evacuado
- Si Rh(–) → **ROGAM**

Seguimiento post-evacuación de mola

TABLA 3.18.3: TIPO VS DURACIÓN DEL SEGUIMIENTO CON BHCG	
TIPO	DURACIÓN DEL SEGUIMIENTO CON BHCG
Mola parcial	≥ 6 meses
Mola completa	≥ 12 meses (mayor riesgo de NTG)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN
Si βHCG **no baja** o se eleva durante el seguimiento → **diagnóstico de NTG** → tratar con histerectomía + quimioterapia.

Neoplasia trofoblástica gestacional

- **Histerectomía** (extirpar tumor primario)
- **Quimioterapia** — los NTG son muy quimiosensibles (incluso el coriocarcinoma con metástasis puede curarse)
- TSIP: menos sensible a quimio, pero menos agresivo → histerectomía suele ser suficiente

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Respecto a Enfermedad Trofoblástica Gestacional (ETG), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Enfermedad Trofoblástica Gestacional (ETG). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Clasificación
- Clínica
- Mola parcial
- Mola completa (βHCG muy elevada → múltiples síntomas)
- Neoplasia trofoblástica gestacional (NTG)
- Diagnóstico
- Imágenes ecográficas de mola

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL (ETG))**PREGUNTA 1**

Respecto a Enfermedad Trofoblástica Gestacional (ETG), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?

- A)** El diagnóstico de Enfermedad Trofoblástica Gestacional (ETG) se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Enfermedad Trofoblástica Gestacional (ETG) debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Enfermedad Trofoblástica Gestacional (ETG) requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Enfermedad Trofoblástica Gestacional (ETG) es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Enfermedad Trofoblástica Gestacional (ETG) no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Enfermedad Trofoblástica Gestacional (ETG)?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Enfermedad Trofoblástica Gestacional (ETG). Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL (ETG)

"" ETG — Mola hidatiforme | — Mola completa (diploide — 46 cromosomas TODOS del padre) | — Mola parcial (triploide — 2 del padre + 1 de la madre; puede tener feto triploide inviable) — Neoplasia trofoblástica gestacional (NTG) — cánceres — Mola invasora — Coriocarcinoma (más agresivo) — Tumor del sitio de inserción placentaria (TSIP) "" 1. Evacuación uterina — AMEU o legrado 2. Molas muy grandes → histerectomía (riesgo de retención de restos) 3. Biopsia del material evacuado 4. Si Rh(–) → ROGAM
:::warning Si β HCG no baja o se eleva durante el seguimiento → diagnóstico de NTG → tratar con histerectomía + quimioterapia. :::